要介護認定調査票・ペルソナ症例 04

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	渡辺 勇（わたなべ いさお）	**年齢 / 性別**	74歳 / 男性
要介護度	要介護1	**調査実施者**	居宅介護支援事業所ケアマネジャー

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】訪問リハビリテーション週2回、通所介護（デイサービス）週2回、福祉用具貸与（歩行器）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】妻（73歳）と二人暮らし。子どもは独立して遠方に居住。
【居住環境】平屋の持ち家。
【主な介護者】妻（主介護者）。
【傷病・既往歴】パーキンソン病（ホーン・ヤール重症度3度）。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	パーキンソン病（ホーン・ヤール重症度3度）
傷病の経過・治療内容	進行性のパーキンソン病により、四肢の筋強剛、振戦、すくみ足、突進歩行が徐々に悪化。生活動作に時間がかかるようになっている。
医学的管理の必要性	レボドパ製剤等の抗パーキンソン病薬の厳格な時間管理による内服調整。リハビリテーションによる身体機能維持。
身体障害に関する意見	四肢の筋緊張亢進、小刻み歩行、すくみ足。寝返りや起き上がりに時間がかかり、バランス不良による転倒リスクが高い。
精神・認知機能の意見	認知機能は保たれているが、身体の自由がきかないことに対する抑うつ傾向および活動性の低下（アパシー）が認められる。
特別医療・ケアの必要性	服薬時間の厳守が極めて重要。また、嚥下機能の軽度低下がみられるため、食事時のむせ込みに注意が必要。
介護に関する医学的意見	病状の進行を防ぐため、訪問リハビリテーションおよびデイサービスでの生活機能訓練の継続が必須。服薬管理の徹底と転倒予防環境の整備を行うこと。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし（筋強剛・振戦あり） (2)
2. 麻痺（下肢）：なし（すくみ足あり） (2)
3. 関節拘縮（上肢）：軽度あり (2)
4. 関節拘縮（下肢）：軽度あり (2)
5. 寝返り：一部介助 (2)
6. 起き上がり：一部介助 (2)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：不安定（突進現象やふらつきあり） (2)
9. 歩行：一部介助・見守り（小刻み歩行、すくみ足） (2)
10. 立ち上がり：一部介助 (2)
11. 片足立ち：不可能 (4)
12. 洗顔：自立（動作緩慢） (1)
13. 爪切り：一部介助（振戦のため妻が補助） (2)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：一部介助 (2)
2. 移動（屋内）：見守りおよび一部介助 (2)
3. 移動（屋外）：一部介助（妻の付き添い、車椅子） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立（早めの声かけ必要） (1)
6. 排泄（排便コントロール）：一部介助（便秘傾向） (2)
7. 衣服着脱（上衣）：一部介助 (2)
8. 衣服着脱（ズボン等）：一部介助 (2)
9. 入浴：一部介助（またぎ、立ち上がりに全面介助） (2)
10. 口腔清潔：自立 (1)
11. 洗髪：一部介助 (2)
12. 買い物：一部介助（妻と同行） (2)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：構音障害・声の小ささが軽度あり (2)
3. 短期記憶：しっかりしている (1)
4. 日付の理解：わかる (1)
5. 場所の理解：わかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：わかる (1)
9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：なし (1)
7. 羞恥心の喪失：なし (1)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：一部介助（妻が時間管理とセットを実施） (2)
2. 金銭管理：自立 (1)
3. 簡単な調理：できない (4)
4. 電話の利用：自立（ハンズフリー利用） (1)
5. 社会的交流：一部介助（デイサービスでのリハビリは楽しみにしている） (2)
6. 日常の意思決定：自立 (1)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

パーキンソン病の進行により運動緩慢、すくみ足が目立ち転倒リスクが高い。認知機能は保たれており自分の病状を理解しているが、身体が動かないことによる抑うつ傾向や意欲低下が見られる。指定時間に正確に通知する服薬管理アプリや歩行リズム補助ツールの活用が適している。